

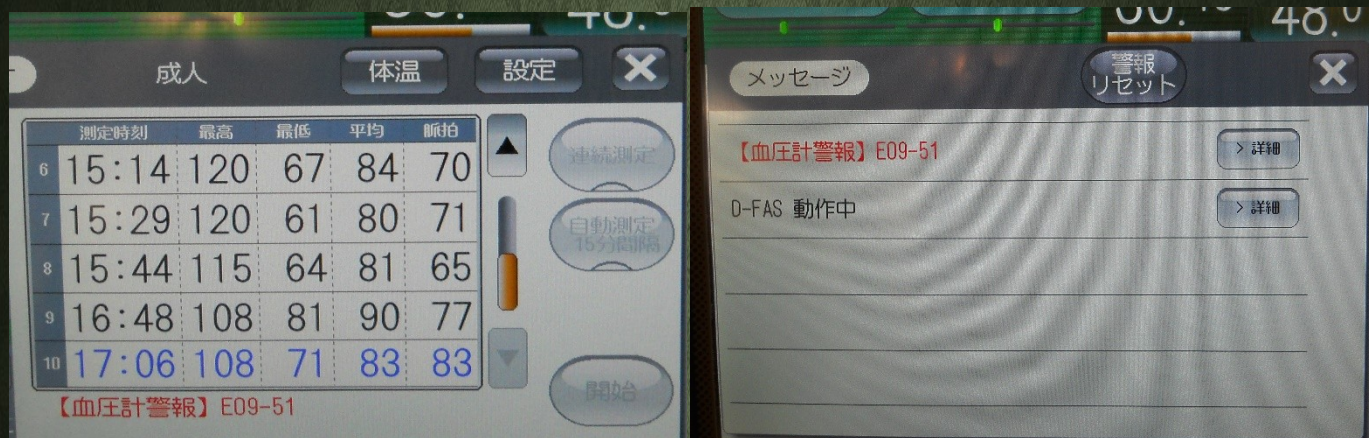
令和7年度 医療機器安全研修

☆もう一度確認しよう！安全透析のための再
チェック

☆コンソールQ&A～よくある疑問を解決～

みたき透析室 重要指名手配

この警報にピンときたら対応！



【血圧計警報】 E09-

51

特徴

- ・体動などにより血圧が測定できなかった時、自動測定タイマーが勝手にOFFになります
- ・高頻度でインシデントを起こす原因になっている凶悪犯です

警報を見つけた方は
血圧を再測定後、
自動測定タイマーを

留意事項

忙しい時の警報はすぐその場を離れたくなりますが警報を止めた場合必ず、**自分で最後まで対応するか他スタッフに依頼してから離れてください**

タイマーOFFにより血圧測定されず
血圧低下に気づかなかった場合、最悪の事態を招き

ます

皆さんの協力が必要です！！！！

インシデント多発中 血圧の再測定忘れ!!

体動で血圧が測れないことが時々ありますが、
もし、**心停止・ショックバイタル・不整脈**な
どで、
血圧が測れていなかった場合、
再測定を忘れてその場を離れても良いと思います
か？

注意

血圧計警報 (E09-51)

再測定 (体動・不整脈)

カフホース点検

測定時間オーバー

脈検出不能

上記以外もあり

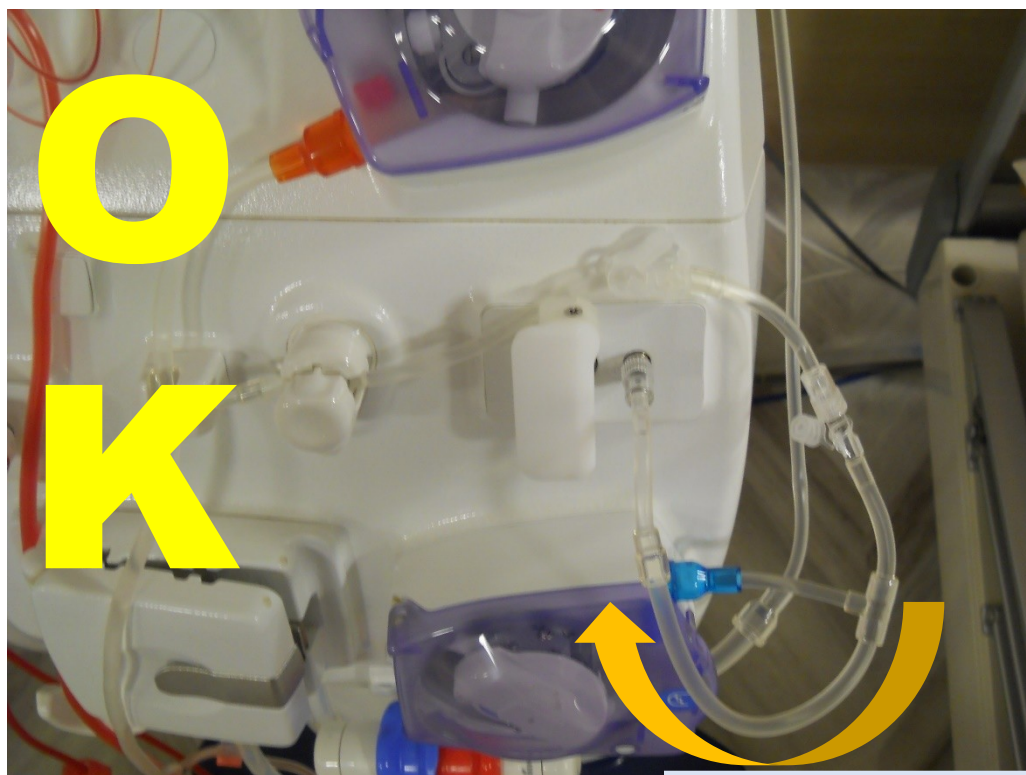
必ず立ち止まって

**警報確認▶患者状態確認▶
警報解除▶警報に対する対**

応

血圧が再測定できるまで
その場を離れないようにしてください

回路折れ曲がりて返血不良が発生しました！



左回りでプライミングポートに
接続してください！！



オンラインHDFの
プライミング時注意してください

右回りだと
折れ曲がりが発生します

不明な点はME伊藤まで

重要!

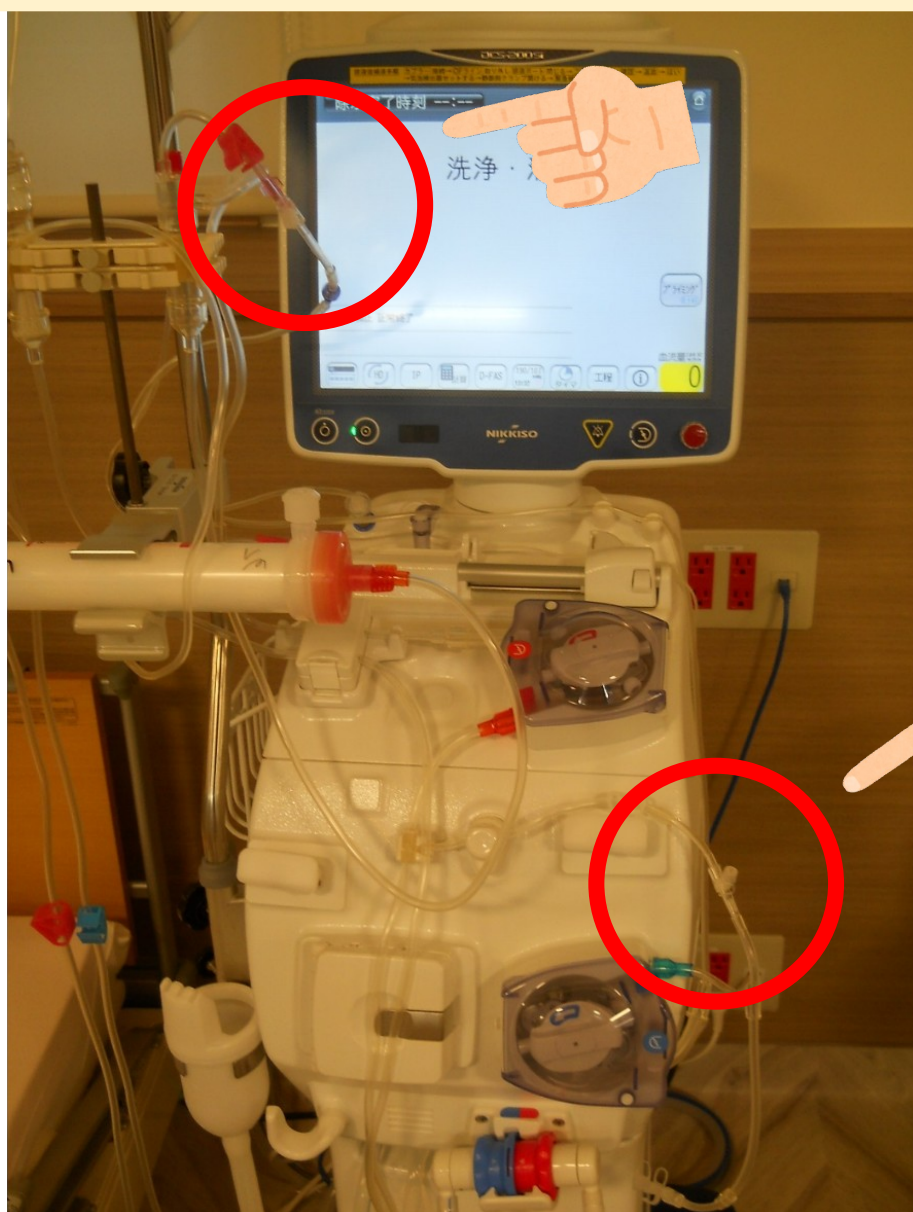
**回路から透析液が漏れ
過除水が発生しました！**

インシデント

オンラインHDFの患者

補液回路の接続部から透析液が少しずつ漏れていた

ロックは締まっていたが押し込みが弱かったためと考えられる
漏れた分が過除水となった

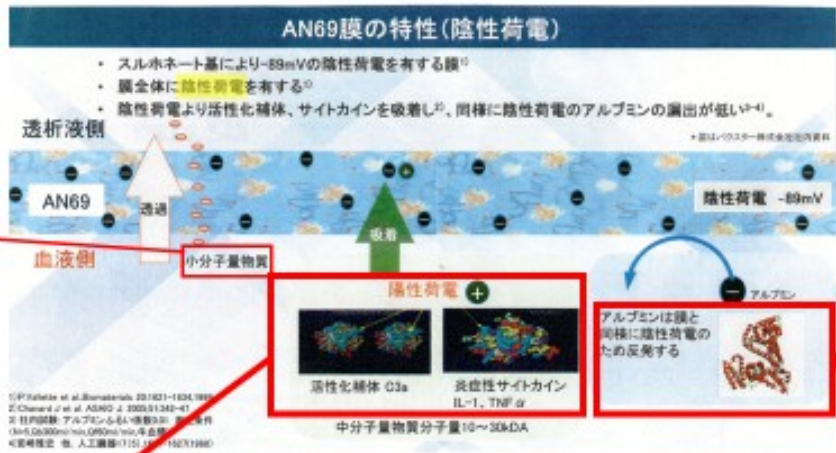


**しっかり押しねじこむ！
しっかり締める！！**

回路からの漏れは
過除水や失血の
大きなリスクです

積層型（AN69膜）の図

積層型の膜は**陰性荷電**（ $\ominus$ になっている）



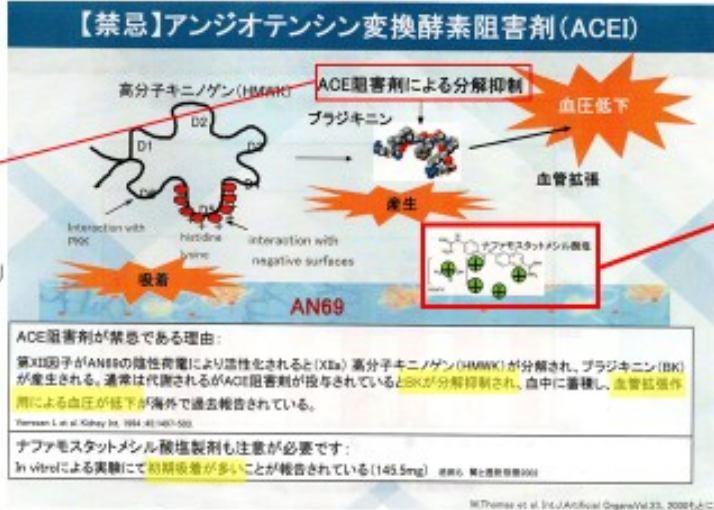
リンやカリウムは問題なく膜を通過し除去される

サイトカインなどの不要物質は $\oplus$ のため膜($\ominus$)が**吸着**してくれる

膜

Albは体内に必要な物質
Albは $\ominus$ のため、膜($\ominus$)と**反発**
→Albが血液から抜けにくい
ためAlb低値の患者に積層型を使用する

積層型と**禁忌**（ナファモスタットとACE阻害薬）



積層を使用するとブラジキニンが産生→本来体内で分解

降圧剤の**ACE阻害薬**には(エースコール等)ブラジキニン分解を抑制効果あり

積層+ACE阻害薬だとブラジキニンが分解されない→ブラジキニンの血管拡張効果により**血圧低下**

ナファモスタットは $\oplus$!!!
積層型の患者に使うと膜($\ominus$)に**吸着**されダイアライザー内にナファモスタットが残り膜がつまる
→いずれダイアライザー内が凝固し**透析継続不能**

逆接続で治療を開始し、シャントチェックの一回目を行った
スタッフも見落とすインシデントが発生しました

「指差し呼称で守る！！いのちと信頼」

☆指差し呼称は自分の確認のためだけではない

もちろん思い込みや見間違いを防ぐという目的が第一です

☆患者さんにも安心を届ける行為

「しっかり確認してくれている」という安心につながります
安全な治療を形で示すことができます

☆仲間にも安全文化を広げる行動

声に出すことで「自分もしっかりやらなきゃ」という意識が広がります

「相手のミスを探す目が患者さんを守る！！」

☆相手を信じすぎない

「間違っているかもしれない」と思って確認しましょう

☆独立して確認する

相手と一緒に見るのではなく自分の目で確かめましょう

☆責任を相手任せにしない

ダブルチェックの人も責任者です

今回のインシデントの患者さんご本人からお声をいただきました。

「声出しをしっかりしているスタッフもいるけど、していないスタッフもいるよ」

みんなで改めて指差呼称、ダブルチェックの大切さを考え、安心安全な
治療を提供していきましょう！！

血液回路をベッドに掛ける際、誤った箇所です鉗子を咬んでしまい、血液回路に亀裂が生じて血液が漏れた事例が発生しました。

鉗子の操作についての説明と注意喚起させていただきます。

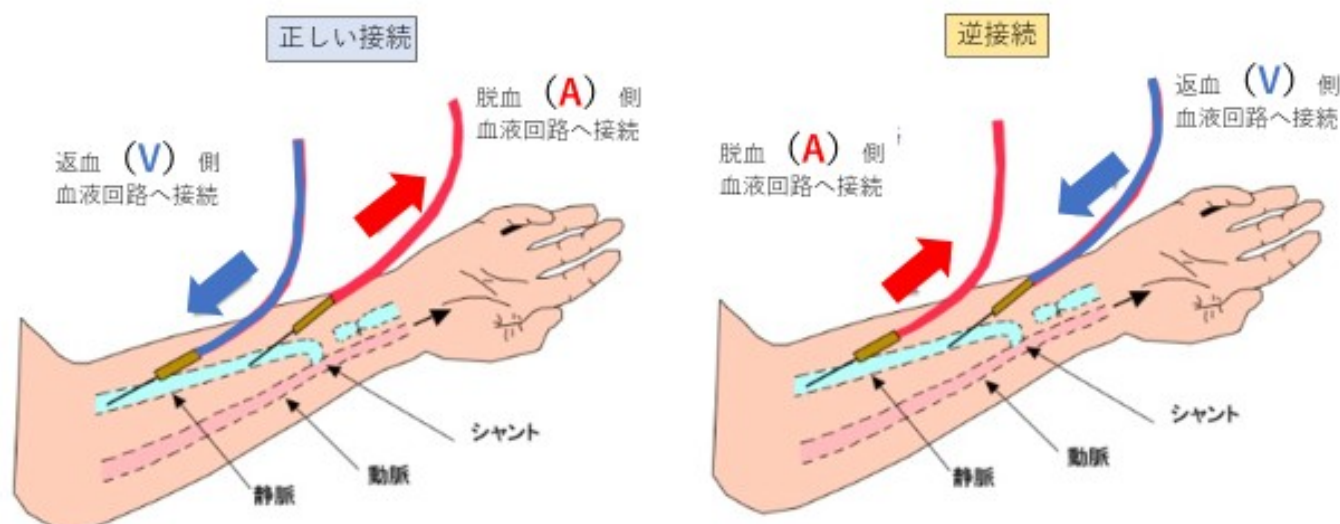
当センターで使用している鉗子は最大3段階はさみ幅を調節できるようになっています。チューブを鉗子で咬む場合は、**2段階**にするようにお願いします。



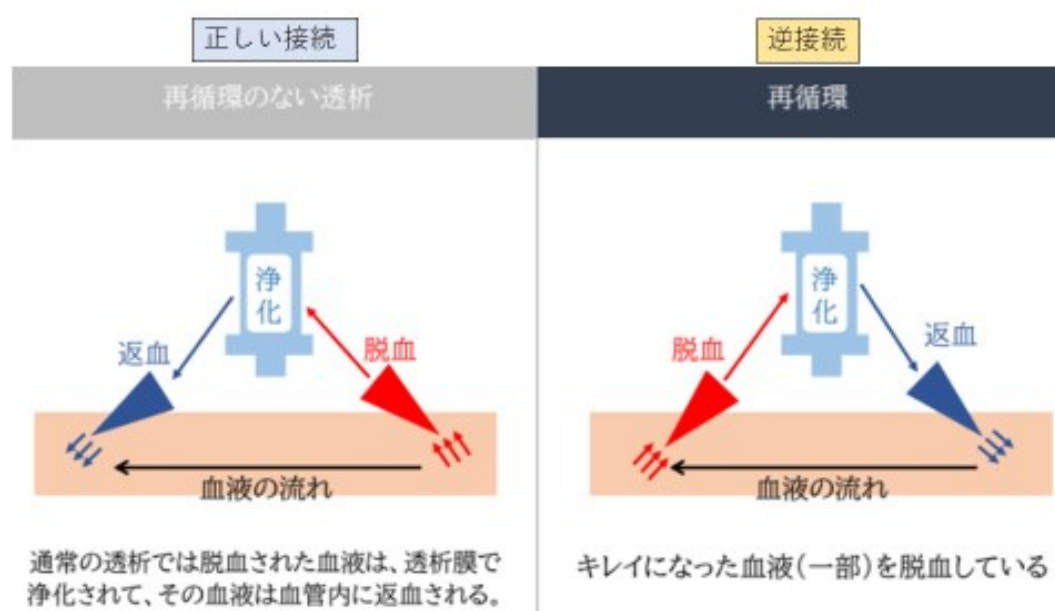
鉗子でチューブを咬む際は、咬む場所の真ん中で咬むようにしてください。



Case1 逆接続



逆接続による再循環

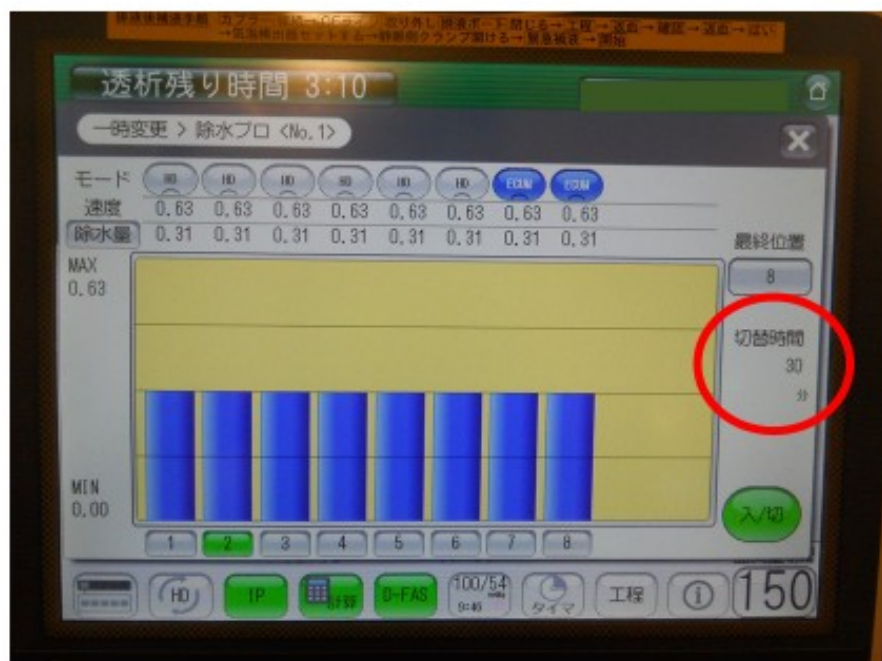
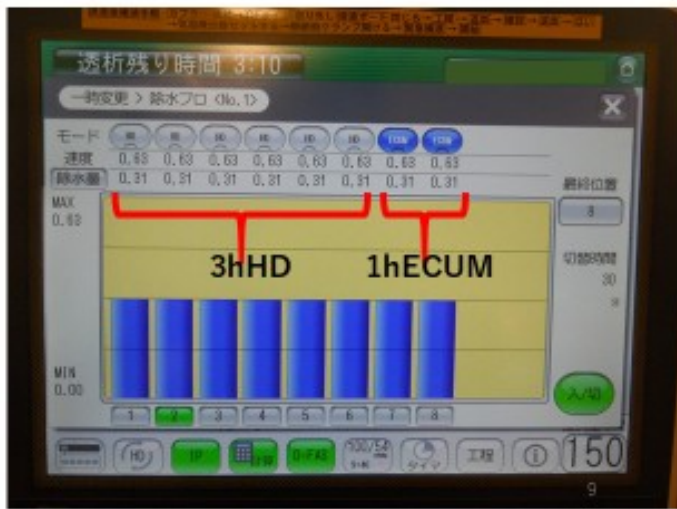


再循環がなぜだめ？

- 透析効率の低下
→ きれいになった同じ血液を再度きれいにしているため
透析効率の低下
- 濃縮による回路凝固
→ 除水して濃くなった血液を再度脱血して
除水しているので、**血液が濃縮され**回路内凝固

Case 2 除水プログラムの切り忘れ

除水プログラムについて



30分に一度
除水速度や
モードの変更が入る

プログラム入

プログラム切



除水速度を0.0L/hrにしたときの注意点

除水速度を0.0L/hrにする（除水をとめる）タイミング

→血圧低下や体調不良時が多い

プログラムが自動変更される時間がきてしまうと

除水が再開されてしまう

除水をとめるべき状況のときに除水が再開されると大事故

→**プログラムをOFFにする**

コンソールのプログラム→「入/切」でOFFにしてください

OFFにすると除水が再開してしまうので

再度、除水速度を0.0L/hrにしてください

プログラムを一度OFFにすると

その透析中はONにすることができません！

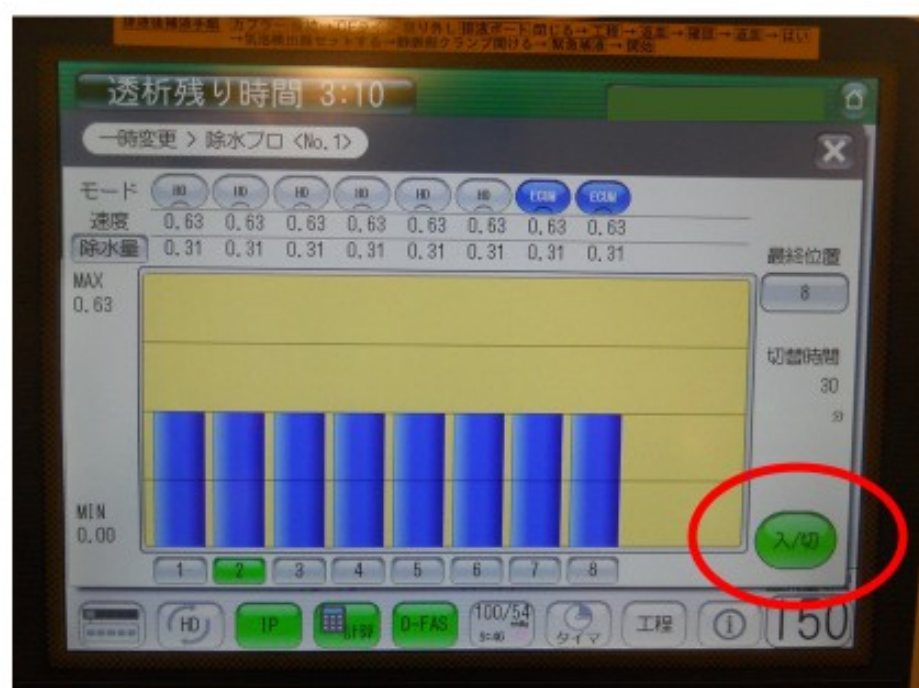
3時間透析+1時間ECUMなどのECUMが入る除水プログラムは

ECUM切り替えタイマーを入れて手動でECUM切り替え、

その他プログラムの場合は医師に相談をしてください

12

13



ここを押して
プログラムをOFFに
してください